

URGENCIAS MÉDICAS EN EL GABINETE DENTAL

Clínica Universitaria de Odontología

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)

Ante una pérdida de conciencia:

1. Asegurarse de la seguridad de la escena.
2. Comprobar que el paciente no responde. Sacudir suavemente a la víctima por los hombros y preguntar en voz alta “¿Se encuentra bien?”.
3. Si la persona no responde, alertar a los Servicios de Emergencia (112), a poder ser activando el “manos libres” del teléfono o pedir a alguien que lo haga.



Comprobar respuesta



Alertar 112

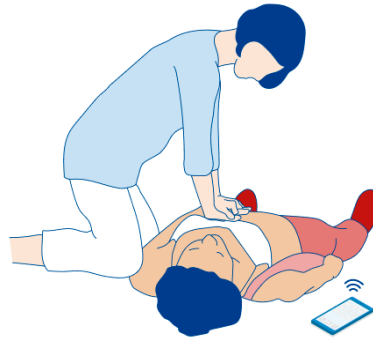
4. Comprobar respiración ausente o anormal, en cuyo caso sospecharemos una parada cardíaca (si no se está seguro, seguir instrucciones del operador). Para ello colocar a la víctima boca arriba, abrir la vía aérea con la maniobra frente-mentón y ver, oír, sentir la respiración durante no más de 10 segundos. Si es posible, solicitar Desfibrilador Externo Automatizado (DEA).



Comprobar respiración

5. Comenzar RCP (Reanimación cardiopulmonar):

- 30 compresiones torácicas:
 - En el centro del pecho
 - 5-6 cm de profundidad
 - 100-120 por minuto



Compresiones torácicas

- 2 ventilaciones de rescate con balón de resucitación y mascarilla. (Si no disponemos de él, seguir con compresiones).
- Continuar con la secuencia 30:2.

6. Encender el DEA en cuanto lo **tengamos** disponible y seguir sus indicaciones audiovisuales:

- Si recomienda una descarga, presionar el botón de descarga asegurándose de que nadie toca a la víctima y reanudar inmediatamente la RCP.
- Si no aconseja descarga, reanudar inmediatamente la RCP.



Descarga segura

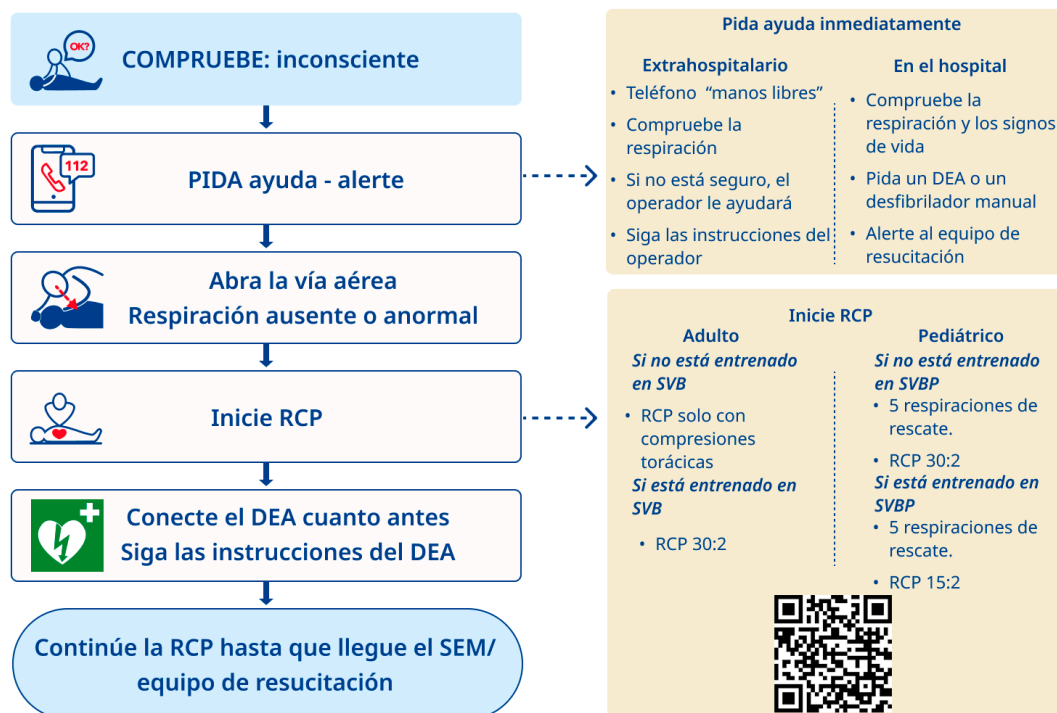


Continuar RCP

Algoritmo de Soporte Vital Básico del European Resuscitation Council (ERC) de 2025

ALGORITMO ERC DE SOPORTE VITAL BASICO

GUIDELINES
2025
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL®



Fuente de imágenes: European Resuscitation Council (ERC)

ATRAGANTAMIENTO. OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO (OVACE)

Ante una persona con obstrucción de la vía aérea (atragantamiento) con tos efectiva:

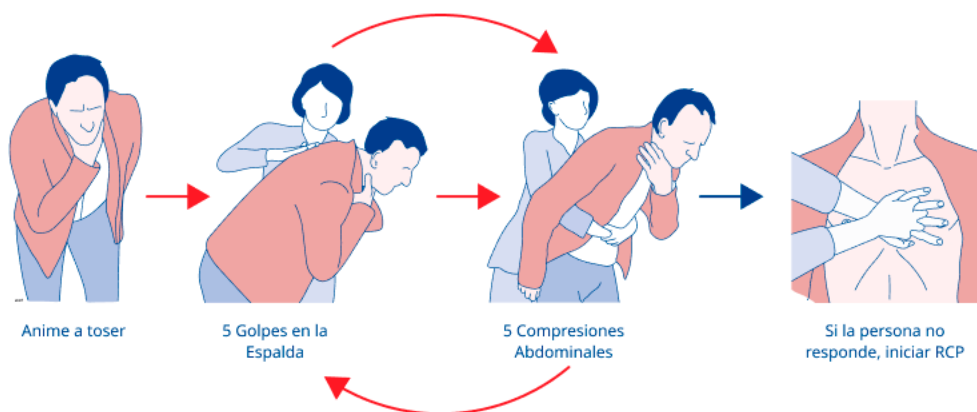
1. Animar a seguir tosiendo.

En cuanto la tos comience a ser inefectiva (no es capaz de toser):

1. Dar hasta 5 golpes interescapulares con el talón de nuestra mano, con la víctima inclinada hacia delante.
2. Si no son efectivos, realizar hasta 5 compresiones abdominales con el puño de una mano agarrado por la otra, abrazando desde atrás al paciente, y aplicándolas entre el ombligo y la caja torácica, hacia dentro y hacia arriba.
3. Continuar alternando 5 golpes interescapulares con 5 compresiones abdominales hasta la resolución de la obstrucción.

Si el paciente pierde la conciencia:

1. Avisar a los Servicios de Emergencia (112).
2. Iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP).



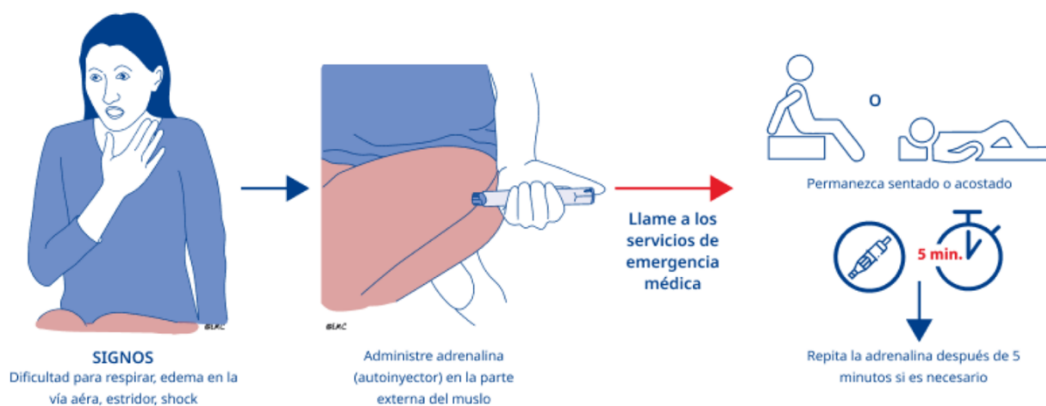
Secuencia de actuación en OVACE. Fuente: European Resuscitation Council (ERC)

REACCIÓN ANAFILÁCTICA

Reconocer la situación, y el posible factor desencadenante:

- Alteraciones en la vía aérea (edema en vía aérea superior)
- Problemas respiratorios (sibilancias o tos persistente)
- Problemas hemodinámicos (tensión arterial baja)
- Alteraciones en piel y mucosas (urticaria, picor, erupciones)
- Problemas digestivos (náuseas/vómitos, dolor abdominal)

1. Alertar a los Servicios de Emergencia (112).
2. Retirar o suspender el agente desencadenante, si es posible.
3. Mantener al paciente tumbado o sentado con piernas extendidas si dificultad respiratoria; que no se siente o levante.
4. Administrar 0,5 mg adrenalina intramuscular en la zona externa del muslo (o autoinyector en caso de disponerlo el paciente).
5. Repetir cada 3-5 minutos si no hay mejoría o reaparecen los síntomas.
6. Proporcione oxígeno al 100% a 15 l/min ajustando para conseguir SatO₂ 94-98% en pulsioxímetro.
7. Evaluar periódicamente.
8. Ante parada cardíaca, iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP).



Actuación ante una reacción anafiláctica. Fuente: European Resuscitation Council (ERC)

ASMA/EPOC. BRONCOESPASMO

Reconocer la situación: paciente asmático/EPOC que comienza con dificultad respiratoria, presencia de sibilancias al respirar, opresión en el tórax, tos sin causa aparente, taquipnea, taquicardia.

1. Alertar a los servicios de Emergencia (112).
2. Tranquilizar al paciente y mantenerle sentado.
3. Administrar salbutamol inhalado (2 puff, repitiendo si no mejoría) o su propio inhalador.
4. Administrar oxígeno (15 l/min).
5. Monitorización de la saturación de O₂ con el pulsioxímetro si es posible, y ajustar flujos para una SatO₂ del 88-92% en caso de EPOC.



Administrar salbutamol inhalado y oxígeno

ICTUS AGUDO

Ante un paciente con alteración neurológica brusca, sospecharemos un ictus.

1. Para valorarla utilizaremos una escala de evaluación. Por ej.: *Escala de ictus prehospitalario de Cincinnati* (CPSS):
 - a. Asimetría Facial: haga que el paciente sonría o muestre los dientes.
 - b. Fuerza en los brazos: haga que el paciente cierre los ojos y mantenga los brazos estirados durante 10 segundos. Un brazo no se mueve o cae respecto al otro.
 - c. Lenguaje: arrastra las palabras, utiliza palabras incorrectas o no puede hablar.
2. Si presenta uno de los tres signos: Alertar a los Servicios de Emergencia (112).

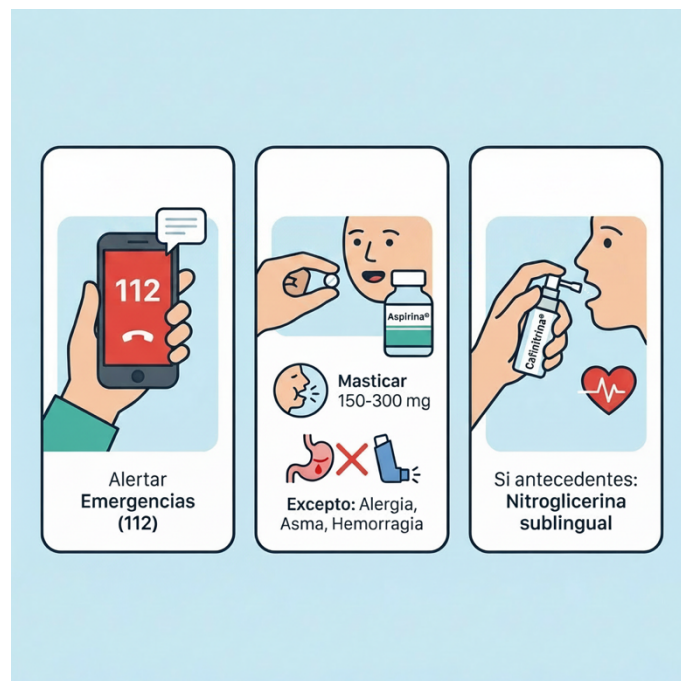


Escala de ictus prehospitalario de Cincinnati

DOLOR TORÁCICO

Sospecharemos origen coronario (angina de pecho/infarto agudo de miocardio, IAM) ante un dolor centrotorácico:

- Opresivo
 - Con irradiación a brazo izquierdo, cuello, mandíbula o espalda
 - Acompañado de cortejo vegetativo (sudoración, náuseas, mareo)
1. Tranquilizar a la víctima.
 2. Mantenerla sentada o tumbada.
 3. Alertar a los Servicios de Emergencia (112).
 4. Administrar 150-300 mg de ácido acetilsalicílico (Aspirina®), vía oral (masticada), salvo dolor traumático, alergia, asma grave o hemorragia gastrointestinal conocida.
 5. Si el paciente tiene antecedentes de patología coronaria administrar aerosol o comprimido sublingual de nitroglicerina (Cafinitrina®).
 6. Evaluar periódicamente.
 7. Ante parada cardíaca, iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP).



Actitud ante dolor torácico de características coronarias

HIPOGLUCEMIA

Sospechar ante paciente diabético o con desnutrición crónica que presenta:

- Cambio repentino en nivel de conciencia, confusión
- Irritabilidad y/o alteraciones de conducta
- Temblores
- Visión borrosa
- Sudor frío, palidez
- Crisis convulsiva
- Mareo, cefalea
- Náuseas

1. Realizar control de la glucemia capilar con glucómetro si es posible, para confirmar la hipoglucemia (< 70 mg/dL).
2. Si está consciente y es capaz de tragar: administrar tabletas de glucosa o dextrosa (15 gramos) o de hidratos de carbono de rápida absorción vía oral.

Por ejemplo:

- 1 vaso de agua con 2 sobres de azúcar
 - 1 vaso pequeño de bebida azucarada tipo cola, naranjada...
 - 1 vaso de zumo de frutas comercial
3. Si a los 15 minutos persiste la clínica o glucemia < 70 mg/dL, repetir dosis.
 4. Si no mejora o pierde la conciencia, alertar a los Servicios de Emergencia (112).
 5. Ante pérdida de conciencia, administrar glucagón im según instrucciones del kit, en brazo o muslo. Puede repetirse la dosis a los 10 minutos si sigue inconsciente.
 6. Si recupera, ofrecer algo de comida (sándwich, galletas...).
 7. Si es posible, mida y registre los niveles de azúcar antes y después del tratamiento.

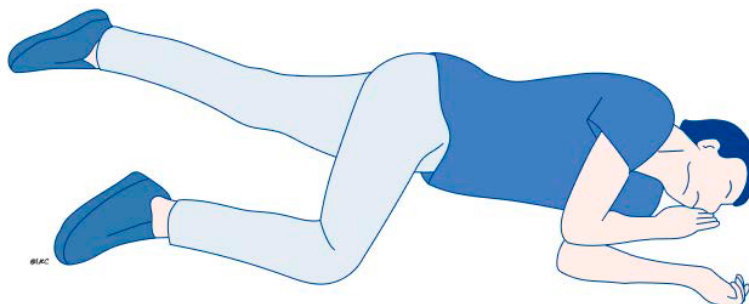
PRESINCOPE/SINCOPE

Sospechar ante: mareos, náuseas, sudoración, palidez, alteraciones en la visión (borrosa, moscas volantes), hipotensión y sensación inminente de pérdida de conciencia.

1. Procurar que la víctima esté segura y que no se caiga o lesione si llegara a perder la conciencia.
2. Colocar al paciente en decúbito supino con las piernas elevadas.
3. Aflojar ropas y tranquilizar al paciente.
4. Si llegara a perder la conciencia (SINCOPE) de forma mantenida, colocar en Posición Lateral de Seguridad y alertar a los Servicios de Emergencia (112).



Actitud inicial ante un presíncope/síncope



Posición lateral de seguridad. Fuente: European Resuscitation Council (ERC)

CRISIS CONVULSIVA

Sospechar ante un paciente que comienza con movimientos tónico-clónicos incontrolables e involuntarios, que pueden acompañarse de pérdida de conciencia, emisión de sonidos, cianosis, emisión de espuma por la boca, etc.

1. Alertar a los Servicios de Emergencia (112).
2. Tumbar al paciente si es posible.
Retirar objetos de alrededor con los que pueda golpearse.
NO introducir nada en la boca (objetos, alimentos ni medicamentos).
NO sujetar con fuerza ni evitar los movimientos.
3. Tras la crisis, colocar al paciente de lado (Posición lateral de seguridad).



Actitud ante una crisis convulsiva